

Cắt Tuyến Tiền Liệt Đơn Giản

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật cho tuyến tiền liệt rất lớn do BPH

Cắt tuyến tiền liệt đơn giản là phẫu thuật dành cho **tuyến tiền liệt rất lớn do tăng sản lành tính (BPH)** gây tắc nghẽn dòng nước tiểu. Bác sĩ phẫu thuật lấy bỏ phần bên trong phình to của tuyến tiền liệt — phần gây tắc — qua đường bụng, mổ hở hoặc mổ nội soi/robot. Phẫu thuật này rất hiệu quả với tuyến tiền liệt rất lớn.

Điểm Khác Biệt Quan Trọng

Cắt tuyến tiền liệt “đơn giản” **không phải** là cắt tuyến tiền liệt “triệt căn” để điều trị **ung thư**. Phẫu thuật triệt căn lấy bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư. Phẫu thuật **đơn giản** chỉ lấy bỏ phần u tuyến (adenoma) bên trong phình to (lành tính) và giữ lại lớp vỏ ngoài — điều trị **tắc nghẽn do phì đại lành tính, không phải ung thư**.

Khi Nào Được Chỉ Định

- Tuyến tiền liệt **rất lớn** không phù hợp với nội soi cắt đốt thông thường (TURP)
- Đặc biệt khi có thêm **sỏi bàng quang** hoặc túi thừa bàng quang lớn cần xử lý
- Các lựa chọn nội soi cho tuyến lớn (**HoLEP, Aquablation**) là các thay thế — bác sĩ sẽ tư vấn phương án phù hợp

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Cắt tuyến tiền liệt đơn giản

Lấy bỏ phần trong phình to của tuyến tiền liệt do BPH (không phải ung thư).

U tuyến (adenoma)

Mô lành tính bên trong tuyến tiền liệt được lấy bỏ.

Cắt tuyến tiền liệt triệt căn

Phẫu thuật khác, lấy bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt để điều trị ung thư.

Mổ hở vs. nội soi robot

Qua một đường rạch lớn, hoặc qua các lỗ nhỏ nội soi.

Xuất tinh ngược dòng

Cực khoái “khô” — hậu quả thường gặp sau phẫu thuật.

Ống thông

Ống dẫn nước tiểu khỏi bàng quang trong vài ngày sau phẫu thuật.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới **gây mê toàn thân**, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Vì đây là phẫu thuật vùng bụng, thời gian hồi phục **lâu hơn nội soi** — dự kiến nằm viện vài ngày (ít hơn với phẫu thuật robot), lưu ống thông vài ngày, và hạn chế hoạt động vài tuần.

Cách Chuẩn Bị

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân** — tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc (ngừng thuốc làm loãng máu theo chỉ dẫn).
- **Xét nghiệm nước tiểu** trước để loại trừ nhiễm trùng.
- Không hút thuốc; sắp xếp người đưa về và hỗ trợ tại nhà.

Quá Trình & Sau Phẫu Thuật

- 1 Bạn được gây mê; kháng sinh được dùng trong lúc mổ.
- 2 Qua đường bụng mổ hở hoặc nội soi robot, phần trong tuyến tiền liệt phình to được lấy bỏ, giữ lại lớp vỏ ngoài.
- 3 Đặt ống thông (và đôi khi một ống dẫn lưu); nằm viện vài ngày (ít hơn với phẫu thuật robot).
- 4 Ống thông thường lưu **vài ngày đến khoảng một tuần**.

Nước tiểu có thể lẫn máu những ngày đầu; **tránh nâng vật nặng và rặn** trong vài tuần.

Kết Quả Mong Đợi

- Cải thiện dòng nước tiểu rõ rệt và bền vững.
- **Xuất tinh ngược dòng** (cực khoái "khô") là phổ biến; ảnh hưởng nghiêm trọng đến cương dương hoặc kiểm soát nước tiểu thì ít gặp.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Không thể đi tiểu** sau khi rút ống thông
- **Chảy máu nhiều hoặc có cục máu đông**, hoặc sốt/ớn lạnh
- Đau bụng tăng dần, hoặc vết mổ đỏ/chảy dịch
- Đau ngực, khó thở, hoặc chân sưng đau (cấp cứu)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Cắt tuyến tiền liệt đơn giản lấy bỏ phần trong phình to do BPH rất lớn — đây **không phải** là phẫu thuật ung thư (vốn lấy bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt).
2. Rất hiệu quả với tuyến lớn; hồi phục lâu hơn nội soi (HoLEP/Aquablation là lựa chọn nội soi thay thế).
3. Dự kiến xuất tinh khô và lưu ống thông vài ngày. Gọi ngay nếu không thể đi tiểu, chảy máu nhiều hoặc sốt.